

Nome: Cecília Maria Albergaria Silva

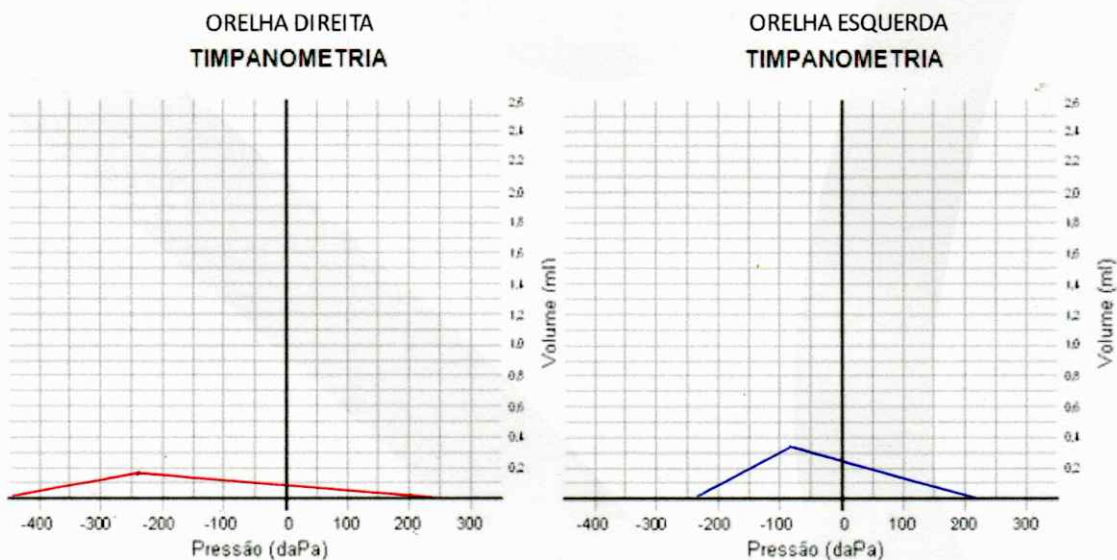
Data de Nascimento: 30/06/2020

Idade: 04 anos

Data do Exame: 14/11/2024

Imitanciômetro: AT235 Interacoustics – Data da calibração: 10/10/2024

IMITANCIOMETRIA



	OD	OE
Volume (ml)	0,39	0,45
Pressão (daPa)	-245	-70
Complacência (ml)	0,18	0,32
Gradiente (ml)	0,03	0,12

REFLEXOS ESTAPEDIANOS

	SONDA NA OD		SONDA NA OE	
	IPSI	CONTRA	IPSI	CONTRA
500 HZ	90	-	80	-
1000 HZ	95	-	80	-
2000 HZ	95	-	90	-
4000 HZ	100	-	95	-

LAUDO: Curvas Timpanométricas Tipo C à direita e Tipo A à esquerda.

Sonda na OD: Reflexos estapedianos ipsilaterais presentes.

Sonda na OE: Reflexos estapedianos ipsilaterais presentes.

Reflexos estapedianos retestados e confirmados.

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO:

Timpanograma: Jerger (1970) e Jerger e Mauldin (1972). Reflexo Acústico: Gelfand (1984); Jerger e Jerger (1989).

Amanda J. Dias de
Fonoaudióloga
CRFa 6-1107

Diagnósticos Avançados e Fonoaudiologia Integrada



**caminho
do som**

+55 (31) 3653. 8407 | 99125.9436

contato@caminhodosom.com.br

Av. Brasil, nº1123 - Funcionários
Belo Horizonte / MG

Nome: Cecília Maria Albergaria Silva

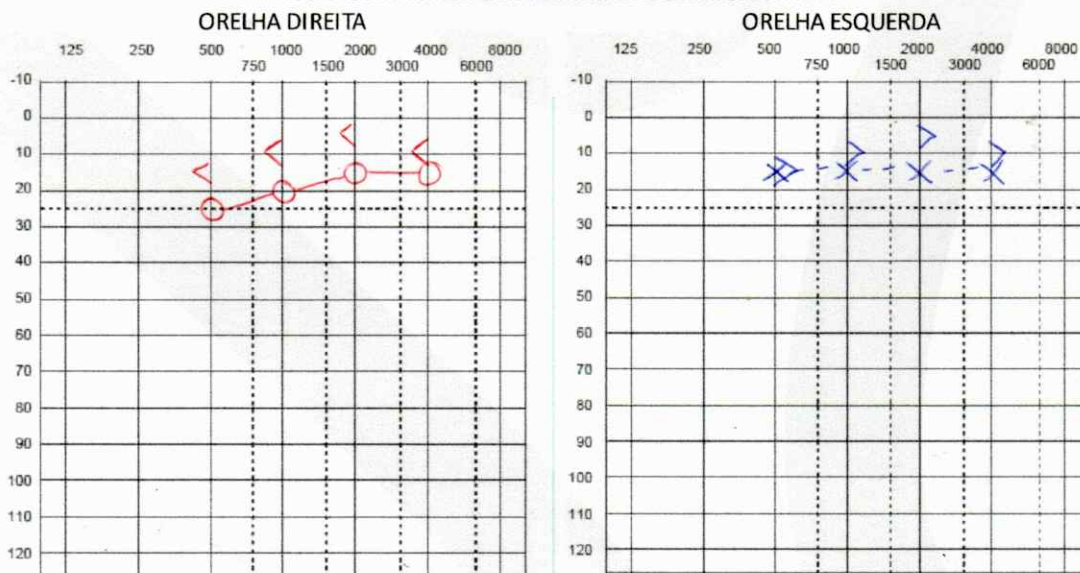
Data de Nascimento: 30/06/2020

Idade: 04 anos

Data do Exame: 14/11/2024

Audiômetro: AC40 Interacoustics – Data da calibração: 12/04/2023

AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR CONDICIONADA



LOGOaudiometria

ORELHA DIREITA			
IPRF	dBNA	%	MASC OE (SN)
Monossílabos	-	-	-
Dissílabos	-	-	-
SRT	25dBNA	-	-
SDT	-	dBNA	-

ORELHA ESQUERDA			
IPRF	dBNA	%	MASC OD (SN)
Monossílabos	-	-	-
Dissílabos	-	-	-
SRT	20dBNA	-	-
SDT	-	dBNA	-

SINAIS CONVENCIONAIS AUDIOMÉTRICOS

Ouvido	Aérea	Óssea	Aérea (ausente)	Óssea (ausente)	Masc. aérea/óssea	Masc. (Ausente)
Direito	O	<	0	0	△	△
Esquerdo	X	>	X	X	□	□

LAUDO:

Orelha direita: Perda auditiva de grau leve.

Orelha esquerda: Limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade.

OBS: Realizada pesquisa de limiares de via aérea da orelha direita e esquerda. Realizada melhor via óssea, sem uso do mascaramento. Diante do resultado da Imitancimetria, infere-se presença de componente condutivo à direita. Exame realizado com o uso de fones auriculares, sob condicionamento lúdico, com 2 fonoaudiólogas. Respostas retestadas, confirmadas e consistentes.

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO:

Tipo: Silman e Silverman, 1997; Grau: OMS, 2014; Configuração: Silman e Silverman adaptado de Carhart (1945) e Dymally (1978).

Bruna Stefanie Pereira
Bruna Stefanie Pereira
Fonoaudióloga
CRFa. 6-11814

Amanda J. Dias de Souza
Fonoaudióloga
CRFa. 6-11872

Classificação do timpanograma de acordo com Jerger (1970) e Jerger e Mauldin (1972).

Tipo da Curva	Definição	Valor de Referência
Tipo A	Mobilidade normal do sistema tímpano-ossicular.	Volume (complacência): 0,30 ml a 1,65 ml. Pressão pico: em torno de 0 da Pa podendo desviar até -100 daPa.
Tipo Ar	Amplitude reduzida. Baixa mobilidade do sistema tímpano-ossicular.	Volume (complacência): abaixo de 0,30 ml. Pressão pico: em torno de 0 daPa podendo desviar até -100 daPa.
Tipo Ad	Amplitude aumentada. Hipermobilidade do sistema tímpano-ossicular.	Volume (complacência): acima de 1,65 ml. Pressão pico: em torno de 0 daPa podendo desviar até -100 daPa.
Tipo C	Pico deslocado para pressão negativa.	Volume (complacência): 0,30 ml a 1,65 ml. Pressão pico: desviado para pressão negativa superior a -100 daPa.
Tipo B	Ausência de mobilidade do sistema tímpano-ossicular.	Curva plana sem pico de máxima complacência ou com complacência muito reduzida.

Classificação do timpanograma de acordo com Katz (1994) e Munhoz (2000).

Tipo da Curva	Definição	Valor de Referência
Tipo P	Pico deslocado para pressão positiva. Relaciona a infecções de vias aéreas superiores ou quadros iniciais ou finais de disfunção tubária.	Volume (complacência): 0,30 ml a 1,65 ml Pressão pico: superior a + 50 daPa

Classificação do reflexo acústico contralateral de acordo com Gelfand (1984); Jerger e Jerger (1989)

Presente	Presente em níveis normais.	Reflexo desencadeado entre 70 e 100 dB acima do limiar da via aérea.
Presente	Presente e diminuído.	Diferença menor ou igual a 65 dB entre o limiar de via aérea e o reflexo estapediano contralateral.
Presente	Presente e aumentado.	Diferença maior que 100 dB entre o limiar de via aérea e o reflexo estapediano contralateral.
Ausente	Reflexo não desencadeado até a saída máxima do equipamento.	---

Tipo de perda auditiva de acordo com Silman e Silverman (1997).

Tipo de perda	Características
Perda auditiva condutiva	Limiares de via óssea menores ou iguais a 15 dB NA e limiares de via aérea maiores que 25 dB NA, com gap aéreo-ósseo maior ou igual a 15 dB.
Perda auditiva sensorioneural	Limiares de via óssea maiores do que 15 dB NA e limiares de via aérea maiores que 25 dB NA, com gap aéreo-ósseo de até 10 dB.
Perda auditiva mista	Limiares de via óssea maiores do que 15 dB NA e limiares de via aérea maiores que 25 dB NA, com gap aéreo-ósseo maior ou igual a 15 dB.

Grau de perda auditiva de acordo com a Organização Mundial da Saúde (2014).

Grau de perda auditiva	Média entre as frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, e 4000Hz (crianças de até 7 anos de idade)	Desempenho
Audição normal	0 - 15dB	Nenhuma ou pequena dificuldade; capaz de ouvir cochichos.
Leve	16 - 30dB	Capaz de ouvir e repetir palavras em volume normal a um metro de distância.
Moderado	31 - 60dB	Capaz de ouvir e repetir palavras em volume elevado a um metro de distância.
Severo	61 - 80dB	Capaz de ouvir palavras em voz gritada próximo a melhor orelha.
Profundo	> 81dB	Incapaz de ouvir e entender mesmo em voz gritada na melhor orelha.

Configuração da curva audiométrica de acordo com Silman e Silverman (1997) adaptada de Carhart (1945) e Lloyd e Kaplan (1978)

Tipo de configuração	Características
Ascendente	Melhora igual ou maior que 5 dB por oitava em direção às frequências altas.
Horizontal	Limiares alternando melhora ou piora de 5 dB por oitava em todas as frequências.
Descendente leve	Piora entre 5 a 10 dB por oitava em direção às frequências altas.
Descendente acentuada	Piora entre 15 a 20 dB por oitava em direção às frequências altas.
Descendente em rampa	Curva horizontal ou descendente leve com piora ≥ 25 dB por oitava em direção às frequências altas.
Em U	Limiares das frequências extremas melhores que as frequências médias com diferença ≥ 20 dB.
Em U invertido	Limiares das frequências extremas piores que as frequências médias com diferença ≥ 20 dB.
Em entalhe	Curva horizontal com descendência acentuada em uma frequência isolada, com recuperação na frequência subsequente.